

CAPÍTULO 8.2

Diarrea Aguda, Crónica y Constipación

PERFIL EUNACOM 1.04.1.026
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definiciones

- La diarrea se define bajo dos parámetros principales que alteran el hábito defecatorio basal del paciente:
- Consistencia:** Disminución de la consistencia (deposiciones más blandas o acuosas).
- Frecuencia:** Aumento en el número de deposiciones, considerando patológico **más de 3 veces al día**. (Lo normal es desde 3 veces al día hasta una vez cada 3 días).

Clasificación según temporalidad

TABLA 8.2.1: TIPO VS DURACIÓN	
TIPO	DURACIÓN
Aguda	< 2 semanas
Prolongada	2 a 4 semanas
Crónica	≥ 4 semanas

Diarrea Aguda

La etiología suele ser infecciosa. Las causas **virales** (como el Rotavirus) son mucho más frecuentes que las **bacterianas** (como *Escherichia coli*).

NOTA CLÍNICA

En la práctica clínica habitual, no se estudia la etiología de cada cuadro de diarrea aguda; el diagnóstico es clínico y el manejo es sintomático. Sin embargo, existe una **vigilancia epidemiológica** mediante "centros centinela" (SEREMI) para monitorear los agentes circulantes en la comunidad.

Manejo de la Deshidratación

El pilar fundamental del tratamiento es la **hidratación**. El método de rehidratación depende del estado hemodinámico y la pérdida de peso estimada:

TABLA 8.2.2: PLAN VS ESTADO DEL PACIENTE		
PLAN	ESTADO DEL PACIENTE	MANEJO
Plan A	Deshidratación leve (<5% pérdida peso) o asintomático.	Sales de Rehidratación Oral (SRO): 100-200 cc tras cada deposición.
Plan B	Deshidratación moderada (5-10% pérdida peso), irritable, mucosas secas, ojos hundidos.	SRO: 50-100 cc/kg en un periodo de 4 a 6 horas. Reevaluar.
Plan C	Deshidratación severa (>10% pérdida peso), signos de shock hipovolémico , compromiso de conciencia.	Hidratación Endovenosa (EV) con cristaloideos (Suero Fisiológico o Ringer Lactato).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente en **Plan B** presenta vómitos, la estrategia es **fraccionar** la hidratación oral (dar a sorbos pequeños o cucharadas) antes de decidir pasar a vía endovenosa.

Excepciones y Consideraciones Especiales

Hipernatremia: Si el paciente está en un estado hiperosmolar con sodio elevado, aunque el suero fisiológico es seguro, para el examen se prefiere marcar el uso de **soluciones hipotónicas (0,45%) o glucosalinas**. **Indicaciones de Hidratación Endovenosa:** 1. Shock o deshidratación severa. 2. Compromiso de conciencia (riesgo de aspiración). 3. Íleo paralítico o distensión abdominal progresiva. 4. Vómitos incoercibles que impiden la vía oral. **Acceso**

Vascular Difícil: Niños: Si no se logra vía periférica, se realiza **osteoclisis** (vía intraósea, generalmente en la tibia). **Adultos:** Se prefiere la **denudación venosa** (el catéter intraóseo puede romperse en hueso adulto).

Tratamiento Farmacológico

Antidiarreicos (Loperamida): **NO** se recomiendan en diarrea aguda infecciosa, ya que pueden aumentar el riesgo de complicaciones bacterianas. **Antieméticos:** *Sí se pueden usar si hay vómitos.* **Antiespasmódicos (Viadil):** *Sí se pueden usar para el manejo del dolor cólico.* **Antibióticos:** La regla general es **NO indicar antibióticos**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Excepciones donde *Sí* se usan antibióticos: 1. **Disentería** (sangre en deposiciones): Sospecha de Shigella o E. coli enteroinvasora. 2. **Diarrea del viajero**. 3. **Fiebre persistente** (más de 2-3 días). 4. *Paciente con compromiso del estado general/séptico.*

Elección de Antibiótico: Ciprofloxacino (vía oral) o Ceftriaxona/Cefotaxima (vía EV si está grave). **Casos específicos:** *Vibrio cholerae* (Cólera): Azitromicina. *Campylobacter*: Eritromicina o Azitromicina.

Diarrea Prolongada y Crónica

Diarrea Prolongada (2-4 semanas)

La conducta es **buscar el agente infeccioso**, ya que no es normal que un virus o bacteria común dure tanto tiempo. Se solicita: - Coprocultivo. - Rotatest. - Parasitológico de deposiciones (buscar Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, etc.).

Diarrea Crónica (≥ 4 semanas)

El estudio depende de la sospecha clínica: 1. **Funcional (Síndrome de Intestino Irritable):** Dolor cólico que alivia al defecar, distensión, mucosidad. Tratamiento: Educación, manejo del estrés y, a veces, **antidepresivos tricíclicos** (por su efecto anticolinérgico que estríñe). 2. **Malabsorción:** Esteatorrea (grasa) o lentería (alimentos sin digerir). Estudio: Test de Sudan, prueba de la D-Xilosa, anticuerpos para **Enfermedad Celíaca** y Endoscopia Digestiva Alta (EDA). 3. **Enfermedad Inflamatoria Intestinal:** Hematoquecia, fiebre crónica. Estudio: Colonoscopia. 4. **Cáncer de Colon:** Si hay signos de alarma (baja de peso, anemia, mayor de 50 años). Estudio: Colonoscopia. 5. **Post-antibióticos:** Sospechar infección por Clostridioides difficile.

Diarrea por Clostridioides difficile

Se sospecha en pacientes que han usado antibióticos (o estuvieron hospitalizados/post-parto) en el **último mes**.

- Diagnóstico:**
- PCR para toxina:** Es el examen de elección hoy en día por su mayor sensibilidad.
- Toxinas A y B en deposiciones:** Examen clásico y más barato.
- Tratamiento (Algoritmo):**
- 1. **Metronidazol** oral.
- 2. Si falla (no hay respuesta clínica en una semana): Repetir Metronidazol.
- 3. Si vuelve a fallar: **Vancomicina** oral.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La respuesta al tratamiento de *C. difficile** es **CLÍNICA**. No se debe pedir PCR o Toxinas de control, ya que pueden permanecer positivas mucho tiempo después de la curación.

Constipación (Estreñimiento)

- Se define por:
- **Consistencia:** Deposiciones duras (caprinas o "bolitas").
- **Frecuencia:** Menos de 3 veces por semana.

Manejo de la Constipación

- **Funcional:** Es lo más frecuente. Se trata con educación, aumento de fibra/agua y fármacos proquinéticos como la **Trimebutina**. - **Signos de alarma:** Ante anemia, baja de peso o cambio brusco del hábito en adultos mayores, se debe solicitar **Colonoscopia** para descartar neoplasia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda la regla de los 3: - Diarrea: > 3 veces al día. - Constipación: < 3 veces a la semana.

- **Temas relacionados:**
- **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**
- **Cáncer Colorrectal**
- **Síndrome de Intestino Irritable**
- **Síndrome Hemolítico Urémico**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 26 años presenta cuadro de 24 horas de evolución de deposiciones líquidas frecuentes (8 episodios), con estrías de sangre y mucosidad, dolor cólico intenso, pujo y tenesmo rectal, asociado a fiebre de 38.8 °C. Refiere haber comido mayonesa casera en un cumpleaños."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Diarrea Aguda Inflamatoria / Disentería: caracterizada por fiebre alta, dolor cólico con tenesmo y deposiciones con sangre y pus (frecuente por *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *E. coli* enteroinvasiva). Indicación: Coprocultivo, hidratación oral/EV y antibióticos empíricos (Ciprofloxacino 500 mg c/12h o Azitromicina 500 mg/d por 3-5 días). CONTRAINDICADOS los antidiarreicos opiáceos (Loperamida).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos
- Tratamiento de diarrea aguda: hidratación según grado de deshidratación (Plan A, B o C)
- No usar antidiarreicos en diarrea aguda; antibióticos solo en disentería, *Shigella*, diarrea febril prolongada o diarrea del viajero
- Antibiótico de elección: ciprofloxacino; si grave: ceftriaxona IV
- Diarrea por *Clostridium difficile*: diagnóstico con PCR, tratamiento metro-metro-vanco, respuesta se evalúa clínicamente
- Diarrea crónica: manejo según clínica (funcional, signos de alarma, malabsorción, EII o post-antibióticos)
- Constipación funcional: trimebutina; con signos de alarma: colonoscopia para descartar cáncer
- Hipernatremia en deshidratación: usar suero hipotónico o glucosalino en vez de fisiológico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIARREA AGUDA, CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN)

PREGUNTA 1

Lactante de 8 meses con diarrea hace 3 días, irritable, mucosas secas, ojos hundidos, con pérdida del 7% de su peso. ¿Cuál es el plan de hidratación más adecuado?

A) Plan A: SRO 100-200 cc post deposición

B) Plan B: SRO 50-100 cc/kg en 4-6 horas

C) Plan C: suero fisiológico endovenoso

D) Suero glucosalino endovenoso

E) Agua libre por vía oral

PREGUNTA 2

Paciente de 45 años con diarrea hace 3 semanas que inició 10 días después de completar tratamiento antibiótico por neumonía. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la etiología?

A) Coprocultivo

B) Toxinas A y B para *Clostridium difficile*

C) PCR para *Clostridium difficile*

D) Parasitológico seriado

E) Colonoscopia

PREGUNTA 3

Paciente con diarrea por *Clostridium difficile* completó un ciclo de metronidazol. La PCR sigue positiva pero la diarrea cedió completamente. ¿Cuál es la conducta?

A) Repetir metronidazol

B) Iniciar vancomicina oral

C) Considerar respuesta adecuada y observar

D) Realizar colonoscopia

E) Solicitar toxinas A y B

RESUMEN: DIARREA AGUDA, CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN

Clase que aborda la diarrea aguda, prolongada, crónica y constipación. La diarrea se define como deposiciones blandas/acuosas con más de 3 veces al día, clasificándose en aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas) y crónica (>=4 semanas). El manejo de la diarrea aguda se centra en la hidratación según grado de deshidratación: Plan A (SRO 100-200cc post deposición) para leve, Plan B (50-100cc/kg en 4-6h) para moderada, y Plan C (suero fisiológico IV) para severa. No se usan antidiarreicos; los antibióticos solo se indican en disentería, shigela confirmada o diarrea febril prolongada. La diarrea crónica se estudia según la clínica: funcional (manejo del estrés), signos de alarma (colonoscopia), malabsorción (test de Sudán, D-xilosa), o post-antibióticos (buscar *Clostridium difficile*). La constipación se define como menos de 3 deposiciones/semana, con manejo según causa.